内科含诊断 心脏瓣膜病 ★★★（0~3 题）

左心衰→肺淤血→肺动脉高压（P_2 亢进及通常分裂）→右心衰（肺淤血有所缓解）
超声心动图：首选和金标准（2016）

	二狭（2007）	二闭（2008、2013）	主狭（2013、2016、2026）	主闭（2008、2025）
X 线	梨形心（2013）	慢性：球形心	心影一般不大或靴形心	慢性：靴形心
心尖抬举样搏动	无，可有心前区 / 剑突下抬举样搏动	有	有	有
并发症	最易左心衰、房颤、脑栓塞“衰了疯了”（2014、2019、2020）	易左心衰、房颤、脑栓塞、感染性心内膜炎	最易左室肥厚、心绞痛、晕厥（2019）	最易感染性心内膜炎
心音 额外心音	S1 ↑（2020） 开瓣音（弹性好）	S1 ↓，S2 通常分裂，S3 和 S4 奔马律 心尖收缩中晚期喀喇音（二尖瓣脱垂）	A2 ↓，S2 逆分裂，S4 奔马律	S1 ↓、A2 ↓，S3 和 S4 奔马律
杂音	心尖、舒张中晚期（房颤晚期可消失）、递增 常隆隆样、左侧卧位增强（2013、2020、2024） 局限 G-S 杂音（相对性肺闭： 胸骨左缘 2 肋间舒张早期递减型，2010）	心尖、全收缩期、一贯（2008、2010） 常吹风样 传导（前叶 - 左腋下和左肩胛下、后叶 - 心底） 可致相对性二狭 可有海鸥鸣或乐音（腱索断裂）	胸骨右缘 2 肋间、收缩期、递增递减 常喷射样 向颈部传导（2016）	胸骨左缘 3~4 肋间、舒张期、递减 常叹气样 向心尖传导（2011、2021） A-F 杂音（相对性二狭，2018、2021） 可致相对性主狭
治疗	急性肺水肿 —— 禁用硝普钠、强心苷（窦性心律）用硝酸酯类、呋塞米 介入手术 —— ①有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术 ②无开瓣音：直视分离术 ③二狭合并中重度二闭等：置换术	置换术 修复术	成人：置换术，若老龄重度不耐受 TAVR 儿童青少年非钙化性：分离术	置换术

杂音切入（2015）
一看部位
二看时期
三看器质 or 功能

	器质性	功能性
强度	≥ 3/6 级	≤ 3/6 级
性质	多粗糙	多柔和
震颤	常伴	不伴

心尖舒张期杂音
①风湿性二狭
②慢性严重主闭（Austin-Flint 杂音：心尖舒张期低调、柔和的隆隆样杂音“佛主闭关”）
③流经二尖瓣口血流增加：严重二闭、室缺、动脉导管未闭、甲亢、贫血等“打工人挤地铁”
④左房黏液瘤：杂音随体位改变、肿瘤扑落音、开瓣音迟晚发生
⑤缩窄性心包炎

心尖收缩期杂音
①风湿病、感染性心内膜炎、心梗等致二闭
②左心扩大（左心衰、扩心病、心肌炎、严重贫血等）
③左心肥大（高血压、主狭、肥心病等）
④限心病